

DRGE: Complicações, Evolução e Tratamento

Apostila 4 — Páginas 61 a 80 | Curso de Especialização em Gastroenterologia

DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO

MÓDULO 4



Classificação Endoscópica de Los Angeles

A Classificação de Los Angeles é o sistema internacionalmente aceito para graduar a gravidade da esofagite erosiva ao exame endoscópico. Baseia-se na extensão e distribuição das erosões mucosas observadas na transição esofagogástrica, permitindo uniformizar a linguagem clínica e orientar decisões terapêuticas.

1

Grau A

Uma ou mais erosões mucosas com **≤ 5 mm**, restritas a uma única prega mucosa. Lesões pequenas e isoladas, sem continuidade entre si.

2

Grau B

Uma ou mais erosões com **> 5 mm**, ainda limitadas a pregas individuais, sem confluência entre as pregas adjacentes.

3

Grau C

Erosões **contínuas entre duas ou mais pregas**, mas envolvendo menos de 75% da circunferência esofágica. Doença moderada a grave.

4

Grau D

Erosões comprometendo **75% ou mais** da circunferência do esôfago distal. Representa a forma mais grave da esofagite erosiva.

❏ A progressão do Grau A ao Grau D reflete maior extensão da lesão mucosa, maior risco de complicações e necessidade de tratamento mais intensivo e prolongado.

Por Que a Classificação Importa?

A correta estadiamento endoscópico da esofagite não é apenas um exercício acadêmico — ela tem implicações diretas na conduta clínica, no seguimento e no prognóstico do paciente com DRGE.

Define a Gravidade

A classificação distingue formas leves (Graus A e B) das formas moderadas a graves (Graus C e D), direcionando a intensidade da intervenção. Pacientes com graus mais elevados requerem doses maiores de IBP e acompanhamento mais rigoroso.

Orienta o Tratamento

Graus A e B frequentemente respondem a doses convencionais de inibidores de bomba de prótons. Graus C e D podem exigir terapia em dose dobrada, maior duração de tratamento e reavaliação endoscópica após ciclo terapêutico.

Auxilia no Prognóstico

Estudos demonstram que pacientes com esofagite de alto grau têm maior risco de desenvolver úlceras esofágicas, estenose e Esôfago de Barrett. A gradação inicial serve como baseline para monitoramento longitudinal.

Evolução Natural da DRGE

A DRGE é uma doença crônica e recidivante. Seu curso natural é variável e depende de múltiplos fatores, incluindo a presença de hérnia hiatal, competência do esfíncter esofágico inferior, composição do refluxado e susceptibilidade individual da mucosa. Compreender essa evolução é fundamental para antecipar complicações e planejar o acompanhamento a longo prazo.



A maioria dos pacientes apresenta evolução estável com tratamento adequado. Entretanto, uma fração significativa pode progredir para formas mais graves, especialmente na ausência de adesão terapêutica ou na presença de fatores anatômicos predisponentes, como a hérnia hiatal volumosa.

DRGE Não Erosiva vs. DRGE Erosiva

A distinção entre as formas não erosiva e erosiva da DRGE é clinicamente relevante, pois impacta diretamente o prognóstico, o risco de complicações e a estratégia terapêutica adotada.

DRGE Não Erosiva (NERD)

Forma mais prevalente, correspondendo a aproximadamente 60–70% dos casos de DRGE. A mucosa esofágica encontra-se macroscopicamente normal ao exame endoscópico.

- Sintomas típicos presentes (pirose, regurgitação) com endoscopia normal
- Menor risco de progressão para complicações estruturais
- Diagnóstico depende de pHmetria ou impedancio-pHmetria
- Resposta aos IBPs pode ser menos robusta do que na forma erosiva
- Qualidade de vida comprometida de forma semelhante à forma erosiva

DRGE Erosiva

Caracterizada pela presença de **lesões mucosas visíveis** ao exame endoscópico. Classificada pelos critérios de Los Angeles (A a D), com implicações prognósticas progressivas.

- Maior risco de úlceras, estenoses e metaplasia de Barrett
- Correlação mais direta entre gravidade endoscópica e intensidade sintomática
- Resposta mais previsível e robusta aos IBPs
- Recidiva frequente após suspensão do tratamento (>80% em 6 meses sem manutenção)
- Necessita endoscopia de controle após tratamento em casos de grau C ou D

Principais Complicações da DRGE

A exposição crônica e repetida da mucosa esofágica ao conteúdo ácido e/ou alcalino do refluxo pode resultar em uma série de complicações estruturais e funcionais de gravidade variável. O reconhecimento precoce dessas complicações é essencial para prevenir desfechos desfavoráveis.



Esofagite Erosiva

Complicação mais frequente. Erosões mucosas classificáveis por Los Angeles. Pode evoluir para formas graves com ulcerações e sangramento.



Úlceras Esofágicas

Lesões profundas associadas à DRGE grave. Risco de hemorragia digestiva alta e perfuração. Exigem tratamento intensivo com IBP em dose plena.



Estenose Esofágica

Consequência da inflamação crônica e fibrose cicatricial. Manifesta-se como disfagia progressiva, inicialmente para sólidos. Tratamento: dilatação endoscópica.



Esôfago de Barrett

Metaplasia intestinal do epitélio esofágico. Principal fator de risco para adenocarcinoma esofágico. Requer vigilância endoscópica periódica.

Esôfago de Barrett

O Esôfago de Barrett (EB) é definido como a substituição do epitélio escamoso estratificado normal do esôfago distal por epitélio colunar com metaplasia intestinal especializada. É considerado a principal complicação da DRGE e a única lesão pré-maligna conhecida do adenocarcinoma esofágico.

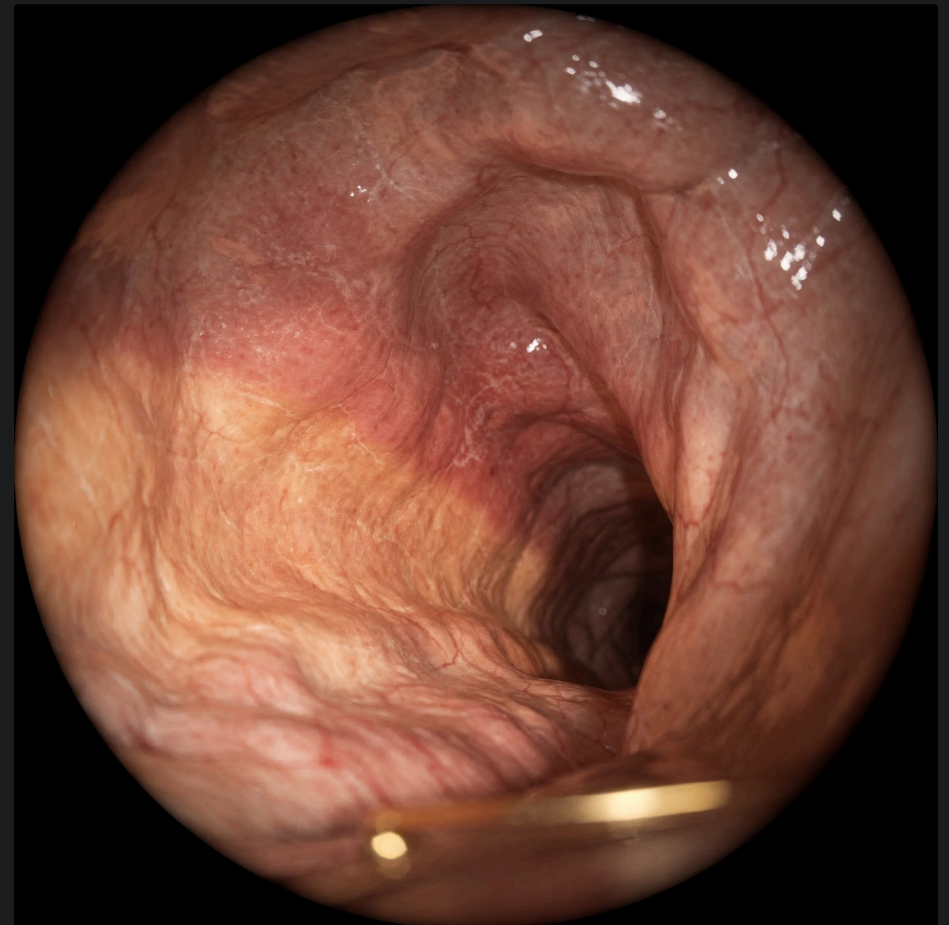
Fisiopatologia e Diagnóstico

A exposição ácida crônica induz dano repetitivo à mucosa escamosa, ativando vias de reprogramação celular que levam à metaplasia colunar. O diagnóstico é estabelecido por endoscopia com biópsias, confirmando a presença de células caliciformes (metaplasia intestinal) ao exame histológico.

- **Endoscopia:** mucosa salmão-avermelhada acima da junção esofagogástrica
- **Histologia:** presença obrigatória de metaplasia intestinal especializada
- **Extensão:** classificado em segmento curto (<3 cm) e longo (≥3 cm)
- Segmento longo associado a maior risco oncológico

Prevalência e Fatores de Risco

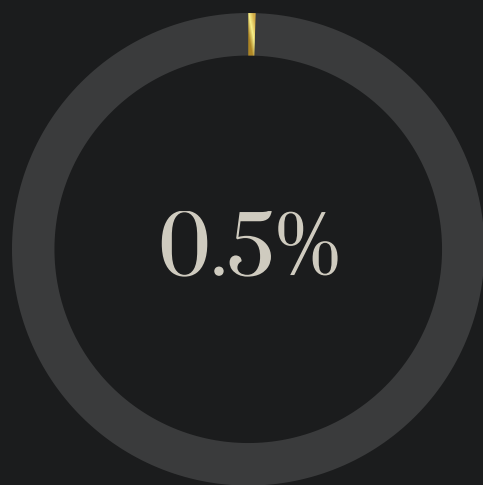
- Estimada em 1–2% da população geral
- Mais comum em homens, brancos, obesos
- DRGE de longa duração é o principal fator predisponente
- Hérnia hiatal, tabagismo e dieta hiperlipídica também associados



📌 **Ponto-chave:** O Esôfago de Barrett é uma lesão pré-maligna. Sua identificação impõe protocolos rigorosos de vigilância endoscópica com biópsias protocoladas para detecção precoce de displasia e adenocarcinoma.

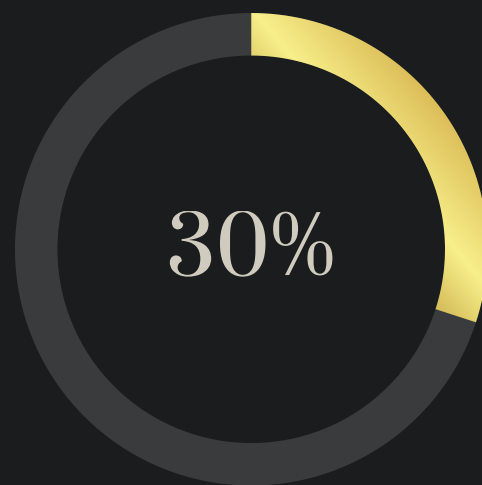
Risco Oncológico no Esôfago de Barrett

A sequência Barrett → Displasia de Baixo Grau → Displasia de Alto Grau → Adenocarcinoma Esofágico é bem estabelecida na literatura médica. O risco de progressão maligna, embora modesto em termos absolutos, justifica protocolos estruturados de vigilância em todos os pacientes com diagnóstico confirmado de EB.



Risco Anual

Taxa de progressão do Esôfago de Barrett sem displasia para adenocarcinoma esofágico por ano de seguimento.



Displasia de Alto Grau

Probabilidade estimada de progressão para adenocarcinoma em casos de displasia de alto grau não tratada em 5 anos.



Aumento de Risco

O Esôfago de Barrett aumenta o risco de adenocarcinoma esofágico em até 11 vezes comparado à população sem DRGE.

Protocolo de Vigilância Endoscópica

01

Barrett sem displasia

Endoscopia a cada 3–5 anos com biópsias de 4 quadrantes a cada 2 cm (protocolo de Seattle). Tratamento com IBP contínuo para suprimir inflamação.

02

Displasia de baixo grau

Confirmação por segundo patologista especializado. Vigilância mais frequente (6–12 meses) ou considerar terapia ablativa endoscópica (radiofrequência).

03

Displasia de alto grau

Indicação de ablação endoscópica (radiofrequência) ou mucosectomia. Cirurgia reservada para casos selecionados. Seguimento intensivo pós-intervenção.

Estenose Esofágica

A estenose esofágica péptica é uma complicação da DRGE crônica e grave, resultante do processo inflamatório repetitivo que leva à fibrose e cicatrização com redução do calibre luminal. Ocorre em aproximadamente 10–15% dos pacientes com esofagite erosiva não tratada adequadamente.

Mecanismo de Formação

A exposição ácida persistente provoca inflamação transmural progressiva na parede esofágica. O processo cicatricial resultante deposita colágeno e tecido fibroso, levando ao estreitamento concêntrico do lúmen esofágico, tipicamente no terço distal do esôfago.

Apresentação Clínica

- **Disfagia progressiva:** inicialmente para alimentos sólidos, evoluindo para semissólidos e, nos casos graves, para líquidos
- Odinofagia pode estar presente
- Impactação alimentar — emergência endoscópica
- Perda de peso e desnutrição em casos avançados
- Piora dos sintomas de refluxo paradoxalmente pode diminuir (menor passagem de ácido)

Diagnóstico e Tratamento

O diagnóstico é confirmado por endoscopia digestiva alta ou esofagograma baritado, que demonstram o estreitamento luminal. A biópsia é fundamental para excluir malignidade.

- **Dilatação endoscópica:** tratamento de escolha, com bougies de Savary ou balões hidrostáticos. Pode necessitar de sessões repetidas
- IBP em dose plena deve ser mantido após dilatação para reduzir recidiva
- Taxa de recidiva da estenose: ~30% em 1 ano sem IBP de manutenção
- Casos refratários: colocação de prótese esofágica ou cirurgia

❏ A disfagia em paciente com DRGE conhecida deve sempre ser investigada com endoscopia para afastar estenose, anel esofágico ou neoplasia.

Úlceras Esofágicas

As úlceras esofágicas representam uma das complicações mais graves da DRGE, caracterizando-se por lesões profundas que ultrapassam a camada mucosa, podendo atingir a submucosa e a muscular própria. Estão fortemente associadas a formas graves de esofagite erosiva (Graus C e D de Los Angeles) e a exposição ácida intensa e prolongada.

Características das Lesões

As úlceras esofágicas pépticas localizam-se predominantemente no terço distal do esôfago, próximas à junção esofagogástrica. São lesões profundas, de base fibrinosa, com bordas bem definidas ao exame endoscópico. Diferem das erosões superficiais pela profundidade e pelo potencial de complicações hemorrágicas.

Complicações e Riscos

As úlceras esofágicas podem causar **hemorragia digestiva alta**, manifestada como hematêmese ou melena — condição que exige abordagem endoscópica urgente para hemostasia. O risco de perfuração, embora raro, é uma emergência cirúrgica. Ademais, a cicatrização fibrótica pós-ulcerativa pode levar à estenose esofágica.

Abordagem Terapêutica

O tratamento baseia-se em IBP em dose dobrada (ex.: omeprazol 40 mg 2x/dia ou pantoprazol 80 mg/dia), mantido por **8 a 12 semanas**. Endoscopia de controle é obrigatória para confirmar cicatrização completa e excluir neoplasia subjacente. Úlceras com estigmas de sangramento recente exigem tratamento endoscópico hemostático.

Complicações Extraesofágicas da DRGE

O Consenso de Montreal (2006) reconheceu formalmente as manifestações extraesofágicas da DRGE, dividindo-as em **síndromes com associação estabelecida** e **síndromes com associação proposta**. O mecanismo envolve microaspiração do conteúdo gástrico e/ou reflexos vagais deflagrados pelo ácido no esôfago distal.



Manifestações Pulmonares

O refluxo crônico é fator desencadeante ou agravante de **asma brônquica**, especialmente de difícil controle. A microaspiração ativa receptores de irritação nas vias aéreas, induzindo broncoespasmo reflexo. Estima-se que 40–80% dos asmáticos apresentam DRGE concomitante.



Tosse Crônica

A tosse crônica de origem esofágica ocorre por estimulação de receptores vagais no esôfago distal, sem necessidade de microaspiração. É uma das três causas mais frequentes de tosse crônica, juntamente com gotejamento pós-nasal e asma. O diagnóstico presuntivo é feito por exclusão e resposta ao IBP.



Pneumonia Aspirativa

A **pneumonia aspirativa recorrente** é uma complicação grave, especialmente em pacientes com refluxo volumoso, disfagia concomitante ou distúrbios neurológicos. O conteúdo gástrico microaspirado provoca inflamação química e infecção bacteriana secundária nas vias aéreas inferiores.



Laringite por Refluxo

Manifestações otorrinolaringológicas incluem rouquidão, globus faríngeo, pigarro crônico e sensação de queimação na garganta. A **laringoscopia** pode revelar eritema e edema das aritenoides. Também chamada de doença do refluxo laringofaríngeo (LPR), requer terapia prolongada com IBP.

DRGE e Doenças Funcionais Associadas

A DRGE raramente se apresenta de forma isolada. Existe sobreposição frequente com outros distúrbios funcionais do trato digestivo e com condições relacionadas ao eixo cérebro-intestino. Reconhecer essa comorbidade é essencial para evitar condutas inadequadas e garantir abordagem integral ao paciente.

Sobreposição com Dispepsia Funcional

Até **40% dos pacientes com DRGE** apresentam concomitantemente sintomas de dispepsia funcional (plenitude pós-prandial, empachamento precoce, dor epigástrica). A sobreposição dificulta a atribuição dos sintomas a uma única entidade, podendo levar a investigação inadequada e resposta parcial ao IBP isolado.

Síndrome do Intestino Irritável (SII)

A SII coexiste com DRGE em uma parcela significativa dos pacientes — especialmente mulheres jovens. Ambas compartilham hipersensibilidade visceral como mecanismo fisiopatológico comum. A presença de SII pode amplificar a percepção dos sintomas de refluxo e reduzir a qualidade de resposta ao tratamento convencional.

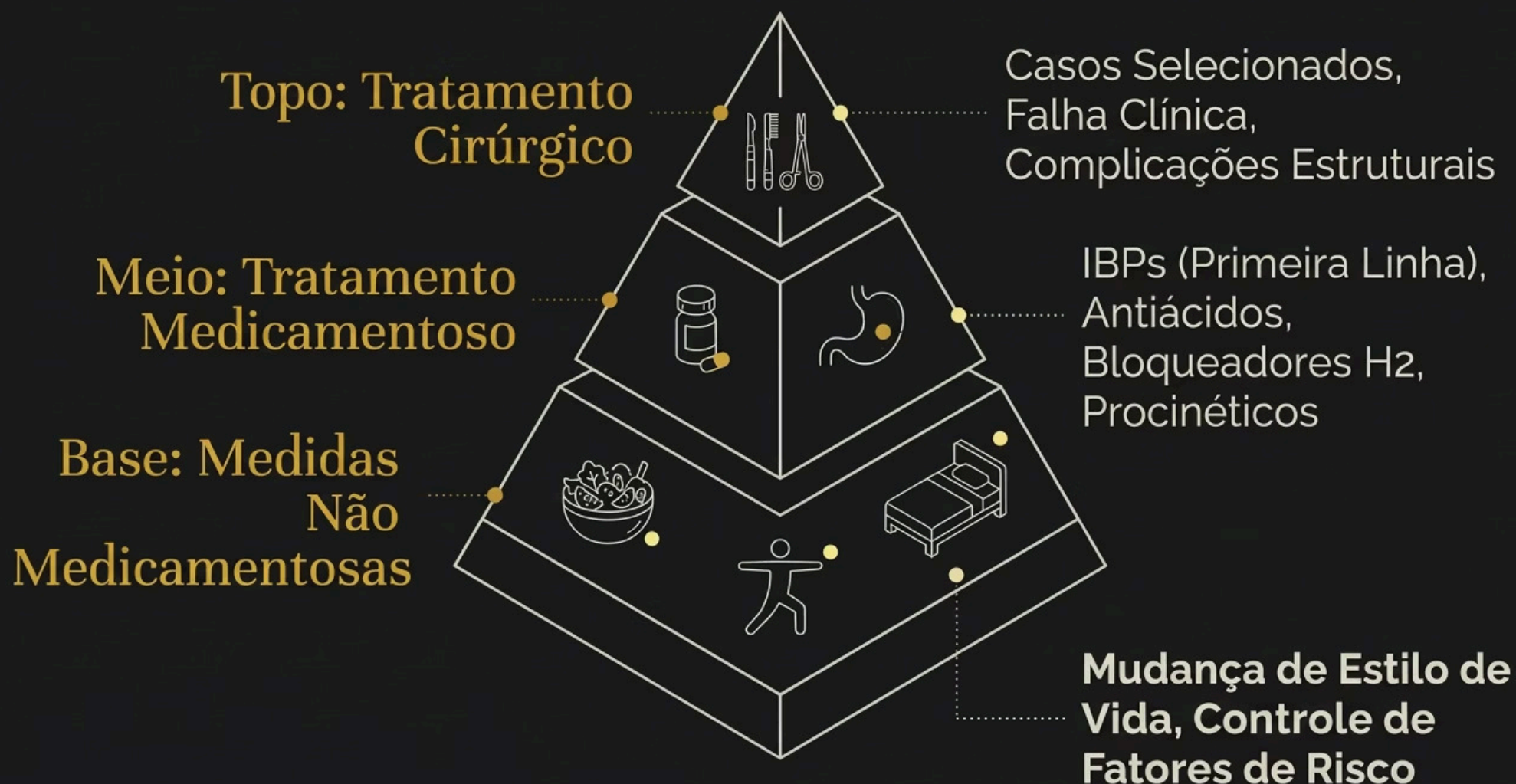
Transtornos Psicológicos e Psiquiátricos

Ansiedade, depressão e transtorno de somatização são significativamente mais prevalentes em pacientes com DRGE sintomática, especialmente na forma não erosiva. Os mecanismos propostos incluem hipersensibilidade visceral central, modulação descendente alterada da dor e amplificação cortical de sinais esofágicos normais.

- Ansiedade aumenta percepção de pirose e regurgitação
- Pacientes com NERD frequentemente têm escores mais altos de catastrofização da dor
- Abordagem psicológica adjuvante (TCC, mindfulness) demonstra benefício em estudos clínicos
- A identificação de comorbidades psiquiátricas deve fazer parte da avaliação inicial do paciente com DRGE refratária

Estratégia Geral de Tratamento da DRGE

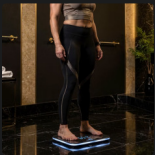
O tratamento da DRGE é individualizado e estruturado conforme a **intensidade dos sintomas**, a **presença de complicações endoscópicas** e o **impacto na qualidade de vida** do paciente. A abordagem deve ser escalonada, iniciando pelas medidas comportamentais e avançando para intervenções farmacológicas ou cirúrgicas conforme a necessidade.



A escolha e a intensidade do tratamento são orientadas pela avaliação clínica completa: frequência e intensidade dos sintomas, achados endoscópicos, resposta a tratamentos anteriores e presença de complicações como estenose, Barrett ou úlceras. A qualidade de vida do paciente é um desfecho terapêutico tão relevante quanto a cicatrização mucosa.

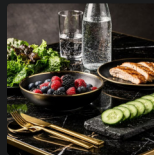
Tratamento Não Medicamentoso

As medidas comportamentais e de estilo de vida constituem a **base do tratamento em todos os pacientes com DRGE**, independentemente da gravidade. Embora isoladamente insuficientes para controlar casos moderados a graves, são complementares indispensáveis ao tratamento medicamentoso e podem reduzir significativamente a frequência e a intensidade dos sintomas.



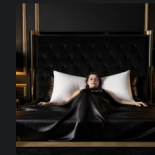
Perda de Peso

A obesidade é o principal fator de risco modificável para DRGE. A perda de **5–10% do peso corporal** reduz significativamente a pressão intra-abdominal, melhora a competência do esfíncter esofágico inferior e diminui o número de episódios de refluxo. É a medida com maior evidência científica de eficácia.



Evitar Alimentos Gatilho

Alimentos que relaxam o esfíncter esofágico inferior ou aumentam a secreção ácida devem ser identificados e evitados individualmente: gorduras, chocolate, café, bebidas carbonatadas, menta, alho, cebola e frutas cítricas. A orientação nutricional personalizada aumenta a adesão às restrições.



Posicionamento e Hábitos Pós-refeição

Evitar deitar-se nas **2–3 horas após as refeições** é fundamental, pois o decúbito facilita o refluxo por eliminação do efeito gravitacional. A elevação da cabeceira da cama em 15–20 cm (não apenas dos travesseiros) reduz o refluxo noturno e é especialmente útil em pacientes com sintomas noturnos ou laringite por refluxo.

Controle de Fatores de Risco Comportamentais

Além das modificações dietéticas, o controle de hábitos de vida representa uma estratégia terapêutica essencial na DRGE. Esses fatores exercem efeito direto sobre a competência do esfíncter esofágico inferior, a motilidade esofagogástrica e a produção de ácido gástrico.

Suspensão do Tabagismo

A nicotina reduz a pressão basal do esfíncter esofágico inferior, aumenta a secreção ácida gástrica e compromete o clearance esofágico. O tabagismo está associado ao agravamento da esofagite erosiva, maior risco de Esôfago de Barrett e menor resposta ao tratamento farmacológico. A cessação tabágica deve ser fortemente incentivada e suportada com recursos específicos.

Redução do Alcool

O álcool atua como duplo agressor: relaxa o esfíncter esofágico inferior e tem efeito irritante direto sobre a mucosa esofágica. O consumo elevado está associado à maior frequência de episódios de refluxo e à menor eficácia dos IBPs. A orientação deve incluir redução significativa ou abstinência, especialmente em casos de esofagite grave.

Ajuste Alimentar Estrutural

Além de evitar alimentos gatilho, recomenda-se fracionamento das refeições em **5–6 porções menores ao dia**, evitar refeições copiosas noturnas e reduzir ingestão de carboidratos fermentáveis. O excesso de carboidratos no estômago aumenta a fermentação e produção de gás, elevando a pressão intragástrica e facilitando o refluxo.

Revisão de Medicamentos

Diversos fármacos podem agravar a DRGE: bloqueadores de canais de cálcio, anticolinérgicos, nitratos, benzodiazepínicos, opioides, AINEs e bifosfonatos orais. A revisão da prescrição e, quando possível, a substituição por alternativas com menor impacto esofágico devem ser consideradas em pacientes com DRGE de difícil controle.

Tratamento Medicamentoso: IBPs — Padrão Ouro

Os **Inibidores da Bomba de Prótons (IBPs)** são o pilar central do tratamento farmacológico da DRGE. Atuam bloqueando irreversivelmente a H⁺/K⁺-ATPase (bomba de prótons) das células parietais gástricas, suprimindo a produção de ácido de forma potente e prolongada — independente do estímulo que a desencadeou (histamina, gastrina ou acetilcolina).

Principais IBPs Disponíveis

Medicamento	Dose Padrão	Dose Dupla
Omeprazol	20 mg/dia	40 mg/dia
Pantoprazol	40 mg/dia	80 mg/dia
Esomeprazol	40 mg/dia	40 mg 2x/dia
Lansoprazol	30 mg/dia	30 mg 2x/dia
Rabeprazol	20 mg/dia	20 mg 2x/dia

 **Orientação fundamental:** os IBPs devem ser administrados **30 minutos antes da primeira refeição** do dia para atingir eficácia máxima, pois necessitam de bombas ativas (estimuladas pela alimentação) para exercer seu efeito inibitório.

Por Que São o Padrão Ouro?

- Supressão ácida superior a 90% em dose plena
- Cicatrização da esofagite erosiva em 85–95% dos casos após 8 semanas
- Alívio de pirose em 80–90% dos pacientes
- Redução do risco de progressão para Barrett e úlceras
- Perfil de segurança adequado para uso a longo prazo

Duração do Tratamento

- DRGE não erosiva: 4–8 semanas (esquema contínuo ou sob demanda)
- Esofagite Grau A/B: 4–8 semanas contínuas
- Esofagite Grau C/D / Barrett / Úlceras: 8–12 semanas + manutenção

Outras Medicações e Teste Terapêutico com IBP

Embora os IBPs sejam a primeira escolha, outras classes de medicamentos têm papel coadjuvante no manejo da DRGE. Além disso, o teste terapêutico empírico com IBP constitui uma ferramenta diagnóstica valiosa em contextos clínicos específicos.

Medicações Complementares

Antiácidos

Hidróxido de alumínio, carbonato de cálcio, bicarbonato. Oferecem **alívio sintomático rápido** mas breve (30–60 min). Não cicatrizam lesões. Indicados para alívio pontual de pirose, não para tratamento contínuo.

Bloqueadores H₂

Ranitidina (retirada do mercado em vários países), famotidina, cimetidina. Menos potentes que os IBPs. Úteis como **complemento noturno** para suprimir o "ácido breakthrough" noturno em pacientes com sintomas noturnos refratários.

Procinéticos

Domperidona, metoclopramida, bromoprida. Aumentam o tônus do EEI e aceleram o esvaziamento gástrico. Utilizados como **adjuvantes** especialmente quando há dismotilidade associada ou sintomas pós-prandiais predominantes. Uso limitado por efeitos colaterais (metoclopramida: efeitos extrapiramidais).

Teste Terapêutico com IBP

O **teste terapêutico empírico com IBP** consiste na prescrição de IBP em dose plena por 2–4 semanas em pacientes com sintomas típicos de DRGE e sem sinais de alarme, antes de realizar exames complementares.

Como interpretar:

- **Melhora significativa dos sintomas (>50%):** sugestivo de DRGE — resposta que reforça o diagnóstico presuntivo
- **Ausência de resposta:** não exclui DRGE (especialmente NERD), mas indica necessidade de investigação complementar (endoscopia, pHmetria)

O teste tem **sensibilidade de ~75%** e especificidade de ~55% para o diagnóstico de DRGE. É custo-efetivo como abordagem inicial em pacientes sem sinais de alarme (disfagia, perda de peso, sangramento, anemia).

- ❏ Sinais de alarme contraindicam o teste empírico e exigem investigação endoscópica imediata.

Tratamento da DRGE Complicada

Casos de DRGE com complicações estabelecidas — como esofagite Grau C/D, Esôfago de Barrett, úlceras esofágicas ou estenose — exigem uma abordagem terapêutica mais agressiva, prolongada e estruturada, combinando tratamento farmacológico otimizado com vigilância endoscópica sistemática.

Diagnóstico e Estadiamento

Endoscopia com biópsias para classificar a lesão, afastar malignidade e estadiar a extensão do comprometimento mucoso. Definição do grau de Los Angeles e presença de Barrett.

Reavaliação Endoscópica

Endoscopia de controle ao término do ciclo inicial para confirmar cicatrização (esofagite C/D, úlceras) ou verificar resposta histológica (Barrett com displasia). Ajuste terapêutico conforme achados.

1

2

3

4

Tratamento Intensivo Inicial

IBP em dose dobrada por 8–12 semanas. Associação de medidas não medicamentosas rigorosas. Em casos de estenose: dilatação endoscópica na mesma sessão ou programada.

Manutenção de Longo Prazo

IBP em dose plena de manutenção indefinida em pacientes com Esôfago de Barrett, esofagite Grau C/D recidivante ou úlceras esofágicas. Vigilância endoscópica periódica conforme protocolo específico para cada complicação.

📌 **Ponto crítico:** A manutenção do IBP após cicatrização de esofagite grave é fundamental — a taxa de recidiva sem terapia de manutenção é superior a 80% no primeiro ano. O tratamento da DRGE complicada é, na maioria dos casos, uma terapia de por vida.

Tratamento Cirúrgico da DRGE

A cirurgia antirrefluxo é uma opção terapêutica eficaz para pacientes cuidadosamente selecionados, podendo oferecer controle duradouro dos sintomas e redução das complicações. No entanto, não é isenta de riscos e deve ser indicada com critério rigoroso, sempre após falha ou limitações do tratamento clínico otimizado.

Indicações para Cirurgia

- **Falha do tratamento clínico:** persistência de sintomas significativos apesar do uso correto de IBP em dose otimizada
- **Dependência crônica de IBP** em paciente jovem que prefere solução definitiva
- **Hérnia hiatal volumosa** (especialmente paraesofágica) com sintomas obstrutivos ou risco de encarceramento
- Complicações estruturais recorrentes (estenoses de repetição, úlceras refratárias)
- Intolerância ou contraindicação ao uso de IBPs a longo prazo
- Refluxo alcalino/biliar documentado não responsivo ao tratamento clínico

Fundoplicatura de Nissen

A **fundoplicatura laparoscópica de Nissen** é a técnica cirúrgica padrão. Consiste no enrolamento de 360° do fundo gástrico ao redor do esôfago distal, reconstituindo mecanicamente um segmento de alta pressão que simula um esfíncter esofágico inferior competente.

- Eficácia sintomática: 85–90% em 5 anos
- Taxa de reoperação: 5–10% em longo prazo
- Principais complicações: disfagia pós-operatória, síndrome do gas bloat, diarreia
- Alternativa: fundoplicatura parcial (Toupet 270°) — menor taxa de disfagia

❏ A manometria esofágica de alta resolução é obrigatória no pré-operatório para excluir dismotilidade esofágica grave que contraindique a fundoplicatura total.

Critérios Cirúrgicos e Pontos-Chave do Módulo

Para encerrar este módulo, consolidamos os critérios de seleção para cirurgia antirrefluxo e os principais conceitos abordados nas páginas 61–80. Esta síntese é um guia de referência rápida para a prática clínica especializada.

Critérios para Indicação Cirúrgica

→ Sintomas Persistentes

Pirose e/ou regurgitação que persistem apesar de IBP em dose plena e otimizada por pelo menos 12 semanas, com confirmação objetiva de refluxo patológico por pHmetria.

→ Dependência Medicamentosa Crônica

Paciente com necessidade de IBP contínuo por anos, sem possibilidade de retirada, que prefere ou se beneficia de solução cirúrgica definitiva — especialmente em jovens sem comorbidades cirúrgicas.

→ Complicações Estruturais

Hérnia hiatal volumosa, estenoses recidivantes e outras alterações anatômicas que perpetuam o refluxo e não respondem adequadamente ao tratamento conservador.

Resumo dos Conceitos Essenciais — Módulo 4

01

Classificação de Los Angeles (A–D)

Gradua a esofagite erosiva; orienta intensidade e duração do tratamento farmacológico.

02

Esôfago de Barrett

Principal complicação da DRGE; lesão pré-maligna que exige vigilância endoscópica sistemática com protocolo de biópsias.

03

IBPs como Pilar Terapêutico

Padrão ouro no tratamento. Devem ser tomados 30 min antes da refeição. Duração e dose conforme gravidade.

04

Abordagem Escalonada

Medidas comportamentais → Farmacologia (IBP ± adjuvantes) → Cirurgia (casos selecionados).

05

Complicações Extraesofágicas

Asma, tosse crônica, laringite e pneumonia aspirativa devem ser investigadas como manifestações de DRGE.

Referências: Consenso de Montreal, Diretrizes ACG (American College of Gastroenterology), Diretrizes Brasileiras de DRGE e literatura médica especializada.